

ШАРиК digital

Patient Flow Company для стоматологий

Delivery SOP

стандарты производства

Диагностика и внедрения по 7К пациентопотока



OS 2.0

Документ для команды, подрядчиков и контроля качества

Версия 1.0 / внутренний стандарт

00 / EXECUTIVE SUMMARY

Delivery SOP как производственная система

Этот документ фиксирует стандарты производства результата в ШАРiK digital. Его задача - сделать диагностику, внедрение и контроль качества повторяемыми. Каждый специалист должен понимать: мы не выполняем разрозненные digital-задачи. Мы закрываем конкретные потери patient flow по методологии 7K.

Главный производственный принцип

- Если задача не закрывает конкретную потерю пациентопотока, она вторична.
- Любая работа привязывается к одному из 7K: Касание, Кредит доверия, Конкретика, Контакт, Конверсия, Курация, Контроль.
- Результат сдаётся не как «мы сделали», а как «какую потерю нашли, что закрыли, как это влияет на запись, лечение и возврат».

Направление SOP	Связь с 7K	Главный результат
Аудит карт	Касание / Кредит доверия	Понять, как клиника выглядит в точке локального выбора.
Аудит сайта	Конкретика / Контакт / Конверсия	Проверить, помогает ли сайт пациенту понять, поверить и записаться.
Аудит отзывов	Кредит доверия	Оценить силу репутации и риски доверия.
Аудит мессенджеров	Контакт / Конверсия	Проверить скорость, качество ответа и доведение до записи.
Аудит звонков	Контакт / Конверсия / Курация	Понять, теряет ли администратор заинтересованных пациентов.
Аудит CRM	Курация / Контроль	Проверить управляемость заявок, статусов и повторных касаний.
Аудит рекламы	Касание / Конкретика / Контроль	Проверить, не льёт ли реклама трафик в протекающий маршрут.
Аудит конкурентов	Все 7K	Понять, где конкурент выигрывает выбор пациента.
Карта потерь	Все 7K	Собрать выводы в диагностический продукт.
Контроль качества	Контроль	Не выпускать слабые, неподтверждённые и неуправленческие выводы.

01 / OPERATING LOGIC

Единый производственный цикл

Производство ШАРiК digital строится не вокруг исполнителей, а вокруг управляемого цикла:
данные - диагностика - scoring - потери - приоритеты - внедрение - отчёт - повторная оценка.

Этап	Что делаем	Выход
1. Сбор данных	Получаем доступы, открытые источники, скриншоты, записи, CRM-выгрузки, ссылки.	Папка проекта и список доступных данных.
2. Диагностика	Проверяем точки patient flow по SOP: карты, сайт, отзывы, мессенджеры, звонки, CRM, рекламу, конкурентов.	Набор подтверждённых наблюдений.
3. Scoring	Оцениваем потери по 7К и Индексу пациентопотока.	Баллы и критичность зон.
4. Карта потерь	Формируем управленческие выводы: где пациент теряется, почему, что делать первым.	Карта потерь пациентов.
5. Внедрение	Закрываем критические потери или запускаем модуль.	Исправления и артефакты.
6. QA	Проверяем доказательность, связку с 7К, качество формулировок, отсутствие лишних обещаний.	Готовый результат к сдаче.
7. Отчёт	Показываем было / стало, закрытые потери, открытые риски и следующий шаг.	Отчёт по снижению потерь.

Запрещено в производстве

- Сдавать выводы без доказательства: скриншот, запись, ссылка, метрика, пример конкурента или факт из CRM.
- Писать «надо улучшить сайт» без привязки к потере: конкретика, контакт или конверсия.
- Предлагать рекламу, если не проверена обработка, посадочная и путь записи.
- Смешивать вкусовщину с диагностикой: «некрасиво» не является потерей, пока не объяснено влияние на пациента.

02. SOP: Аудит карт

Аудит карт

Связь с 7К: Касание / Кредит доверия

Цель: Понять, насколько клиника выигрывает или проигрывает локальный выбор пациента в Яндекс Картах, 2ГИС и Google Maps.

Входные данные

- Ссылки на карточки клиники во всех картах.
- Список ключевых услуг и геозапросов.
- 3-5 локальных конкурентов.
- Скриншоты рейтинга, отзывов, фото, описания, категорий.
- Доступ к управлению карточками, если есть внедрение.

Последовательность действий

- Проверить наличие и корректность карточек в Яндекс Картах, 2ГИС и Google Maps.
- Сравнить рейтинг, количество отзывов, динамику и тональность с конкурентами.
- Проверить категории, услуги, описание, фото, режим работы, телефоны, ссылки, кнопки записи.
- Оценить ответы на отзывы: скорость, тон, глубина, работа с негативом.
- Проверить визуальную упаковку: фасад, вход, кабинеты, врачи, команда, оборудование.
- Сформировать потери: где пациент может не заметить, не довериться или выбрать конкурента.

Чек-лист диагностики

- Карточки найдены во всех ключевых картах.
- Название, адрес, телефон, график и ссылка актуальны.
- Есть корректные категории и услуги.
- Рейтинг и количество отзывов сравнены с конкурентами.
- Негативные отзывы разобраны отдельно.
- Фото создают доверие, а не случайный визуальный шум.
- Есть понятный следующий шаг: позвонить, перейти, записаться.

Результат на выходе

- Таблица состояния карт.
- Список потерь по картам.
- Сравнение с конкурентами.
- Быстрые правки на 7 дней.
- Рекомендации по модулю репутации и карт.

Критерии качества

- Каждая потеря подтверждена скриншотом.
- Выводы связаны с записью или доверием.
- Конкуренты выбраны в той же географии.
- Нет общих фраз вроде «улучшить карточку».

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Оценивать карты без сравнения с конкурентами.
- Смотреть только рейтинг и игнорировать содержание отзывов.
- Не проверять кнопки, ссылки и телефоны.
- Не отделять быстрые правки от системной работы с репутацией.

03. SOP: Аудит сайта

Аудит сайта

Связь с 7К: Конкретика / Контакт / Конверсия

Цель: Проверить, помогает ли сайт пациенту понять ценность клиники, поверить и сделать шаг к записи.

Входные данные

- URL сайта и ключевых посадочных страниц.
- Мобильная версия.
- Список приоритетных услуг.
- Данные по заявкам и аналитике, если доступны.
- Список конкурентов для сравнения.

Последовательность действий

- Открыть сайт с мобильного и десктопа как пациент.
- Проверить первый экран: понятно ли кто клиника, для кого, что делать дальше.
- Разобрать страницы услуг: конкретика, цены, врачи, доказательства, страхи, СТА.
- Проверить врачей: фото, регалии, специализации, доверие, кейсы.
- Протестировать формы, телефоны, мессенджеры, онлайн-запись.
- Проверить скорость, адаптивность, читаемость, отсутствие технических барьеров.
- Сформировать потери по смыслу, доверию и действию.

Чек-лист диагностики

- Первый экран объясняет выбор за 5 секунд.
- Услуги понятны пациенту, а не только врачу.
- Есть доказательства доверия: врачи, кейсы, отзывы, лицензии.
- СТА видны на ключевых экранах.
- Формы работают и не требуют лишнего.
- Мобильный путь до записи занимает минимум шагов.
- Есть связка с картами, мессенджерами и CRM.

Результат на выходе

- Карта слабых мест сайта.
- Список критических потерь действия.
- Рекомендации по quick fixes.
- ТЗ на модуль сайта или лендинга, если нужно.

Критерии качества

- Выводы показывают, где пациент не понимает, не доверяет или не действует.
- Не подменять аудит сайта дизайнерским вкусом.
- Каждый вывод привязан к этапу patient flow.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Писать «устаревший дизайн» без объяснения потери.
- Не проверять мобильную версию.
- Не тестировать формы и мессенджеры.
- Предлагать новый сайт там, где достаточно правок.

04. SOP: Аудит отзывов

Аудит отзывов

Связь с 7К: Кредит доверия

Цель: Оценить, насколько отзывы помогают или мешают пациенту довериться клинике до первого контакта.

Входные данные

- Отзывы из карт, агрегаторов, соцсетей.
- Динамика за 3-12 месяцев.
- Ответы клиники.
- Отзывы конкурентов.
- Скриншоты негатива и сильных отзывов.

Последовательность действий

- Посчитать количество отзывов по площадкам.
- Оценить свежесть: есть ли новые отзывы за последние 30-60 дней.
- Разобрать тональность и повторяющиеся темы.
- Проверить ответы клиники на позитив и негатив.
- Сравнить репутационный профиль с конкурентами.
- Выделить доверительные пробелы: врачи, боли, цены, сервис, гарантия.

Чек-лист диагностики

- Отзывы свежие и регулярные.
- Есть конкретика по врачам, услугам, результатам.
- Негатив обработан корректно.
- Ответы не шаблонные и не агрессивные.
- Рейтинг конкурентоспособен.
- Отзывы помогают снять страхи пациента.

Результат на выходе

- Репутационная карта.
- Список тем доверия и недоверия.
- Рекомендации по сбору отзывов.
- Сценарии ответов на отзывы.

Критерии качества

- Не считать отзывы только количеством.
- Отдельно фиксировать темы, которые влияют на запись.
- Не обещать удаление негатива как основной метод.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Игнорировать содержание отзывов.
- Копировать шаблонные ответы.
- Не сравнивать с конкурентами.
- Не связывать отзывы с врачами и услугами.

05. SOP: Аудит мессенджеров

Аудит мессенджеров

Связь с 7К: Контакт / Конверсия

Цель: Проверить, не теряется ли пациент после того, как решил написать в клинику.

Входные данные

- Ссылки на WhatsApp/Telegram/VK/виджеты.
- Скрипты переписок, если есть.
- Примеры реальных диалогов.
- Тестовый запрос тайного пациента.
- Регламент времени ответа.

Последовательность действий

- Проверить видимость мессенджеров на сайте, картах и соцсетях.
- Отправить тестовый запрос с пациентским сценарием.
- Зафиксировать скорость первого ответа.
- Оценить тон, конкретику, вопросы и ведение к записи.
- Проверить фиксацию обращения в CRM.
- Проверить повторный контакт, если пациент не ответил.

Чек-лист диагностики

- Мессенджеры легко найти.
- Ответ приходит быстро.
- Администратор задаёт уточняющие вопросы.
- Есть предложение записи, а не только справка.
- Диалог не обрывается после первого ответа.
- Есть follow-up по неответившим.

Результат на выходе

- Анализ переписки.
- Список потерь контакта и конверсии.
- Рекомендации по скрипту.
- Шаблоны сообщений и follow-up.

Критерии качества

- Тест должен быть реалистичным.
- Скорость ответа фиксируется временем.
- Оценка не должна быть эмоциональной - только по критериям.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Проверять только наличие WhatsApp.
- Не смотреть, довели ли до записи.
- Не фиксировать время ответа.
- Не проверять повторное касание.

06. SOP: Аудит звонков и администраторов

Аудит звонков и администраторов

Связь с 7К: Контакт / Конверсия / Курация

Цель: Понять, превращает ли администратор заинтересованный контакт в запись или теряет пациента.

Входные данные

- Сценарий тайного пациента.
- Записи звонков или коллтрекинг.
- Скрипты администраторов.
- Данные по пропущенным и перезвонам.
- CRM-статусы по звонкам.

Последовательность действий

- Провести тайный звонок по реальной услуге.
- Оценить приветствие, выяснение потребности, доверие, цену, предложение записи.
- Проверить работу с возражениями: дорого, подумаю, надо сравнить.
- Проверить, фиксируется ли контакт в CRM.
- Проверить возврат пропущенных и недозвонов.
- Сформировать потери обработки и курации.

Чек-лист диагностики

- Звонок принят быстро или есть перезвон.
- Администратор не просто информирует, а ведёт к записи.
- Есть вопросы по ситуации пациента.
- Цена объясняется без обесценивания.
- Запись предложена конкретно.
- Отказ или “подумаю” не теряется.

Результат на выходе

- Оценка звонка по критериям.
- Список потерь обработки.
- Рекомендации по скрипту.
- План обучения или модуль администраторов.

Критерии качества

- Запись звонка обязательна для доказательства.
- Выводы должны быть привязаны к записи, а не манере речи.
- Не обвинять администратора - показывать системную потерю.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Оценивать по одному звонку без контекста.
- Не проверять пропущенные.
- Не смотреть CRM-фиксацию.
- Писать только «плохо продаёт» без критериев.

07. SOP: Аудит CRM

Аудит CRM

Связь с 7К: Курация / Контроль

Цель: Проверить, управляет ли клиника обращениями, статусами, потерянными заявками и повторными касаниями.

Входные данные

- Доступ в CRM или выгрузка.
- Список статусов.
- Источники обращений.
- Примеры сделок.
- Правила работы администраторов.

Последовательность действий

- Проверить структуру воронки и статусов.
- Оценить обязательные поля: источник, услуга, ответственный, следующий шаг.
- Найти потерянные и зависшие обращения.
- Проверить повторные касания.
- Сверить CRM с звонками, мессенджерами и заявками.
- Проверить отчётность собственника.

Чек-лист диагностики

- Есть понятные статусы.
- Каждое обращение имеет источник и ответственного.
- Есть дата следующего действия.
- Потерянные заявки анализируются.
- Есть возврат “подумаю” и недозвонов.
- Руководитель видит отчёты по patient flow.

Результат на выходе

- Карта CRM-потерь.
- Список статусов для исправления.
- Рекомендации по регламенту.
- ТЗ на интеграции или настройку CRM.

Критерии качества

- Не требовать сложную CRM без необходимости.
- Отделять проблему системы от дисциплины людей.
- Связывать CRM с потерями, а не с “чтобы было красиво”.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Смотреть CRM как программу, а не как контур контроля.
- Не проверять реальные сделки.
- Не смотреть повторные касания.
- Не учитывать работу администраторов.

08. SOP: Аудит рекламы

Аудит рекламы

Связь с 7К: Касание / Конкретика / Контроль

Цель: Проверить, приводит ли реклама пациента в рабочий маршрут или усиливает хаос.

Входные данные

- Доступы к рекламным кабинетам.
- Список кампаний, объявлений, посадочных.
- Данные аналитики и заявок.
- Рекламный бюджет.
- Связка с CRM и коллтрекингом.

Последовательность действий

- Проверить, куда ведёт реклама.
- Оценить оффер и соответствие посадочной.
- Проверить аналитику заявок, звонков и источников.
- Сравнить рекламное обещание с сайтом и обработкой.
- Проверить, нет ли трафика в слабую страницу или форму.
- Сформировать потери на стыке рекламы и записи.

Чек-лист диагностики

- Кампания ведёт на релевантную страницу.
- Оффер понятен и не обманывает ожидания.
- Заявки и звонки связаны с источниками.
- Есть сквозная логика до записи.
- Посадочная выдерживает трафик.
- Реклама не компенсирует дыры обработки.

Результат на выходе

- Диагностика рекламного контура.
- Список рисков бюджета.
- Рекомендации: остановить, исправить, масштабировать.
- ТЗ на рекламный модуль.

Критерии качества

- Не оценивать рекламу только по CTR и лидам.
- Смотреть связь с записью.
- Проверять посадочную и обработку до рекомендаций по бюджету.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Советовать увеличить бюджет без аудита маршрута.
- Игнорировать качество заявок и запись.
- Не сверять CRM.
- Не проверять соответствие оффера странице.

09. SOP: Аудит конкурентов

Аудит конкурентов

Связь с 7К: Все 7К

Цель: Понять, почему пациент может выбрать конкурента вместо клиники, и какие элементы patient flow конкуренты закрывают сильнее.

Входные данные

- 3-7 прямых конкурентов.
- Карты, сайты, отзывы, соцсети, посадочные.
- География и ключевые услуги.
- Скриншоты сильных и слабых мест.

Последовательность действий

- Выбрать конкурентов в той же географии и сегменте.
- Сравнить карты, рейтинг, отзывы, фото.
- Сравнить первый экран сайта и страницы услуг.
- Проверить путь записи и мессенджеры.
- Сравнить офферы, врачей, доказательства, цены.
- Выделить зоны, где конкурент выигрывает patient flow.

Чек-лист диагностики

- Конкуренты релевантны по географии и сегменту.
- Сравнение идёт по 7К, а не “красивее / хуже”.
- Есть скриншоты и ссылки.
- Понятно, что можно перенять, а что не нужно копировать.
- Выводы ведут к приоритетам.

Результат на выходе

- Таблица конкурентных разрывов.
- Карта преимуществ и проигрышей.
- Идеи quick wins.
- Рекомендации для позиционирования и модулей.

Критерии качества

- Не копировать конкурентов слепо.
- Сравнить по пациентскому выбору.
- Показывать только управленчески значимые различия.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Брать нерелевантных конкурентов.
- Сравнить дизайн без patient flow.
- Не проверять путь записи.
- Не фиксировать доказательства.

10. SOP: Подготовка Карты потерь

Подготовка Карты потерь

Связь с 7К: Все 7К

Цель: Собрать результаты диагностики в управленческий продукт, который показывает владельцу клиники потери, приоритеты и следующий шаг.

Входные данные

- Все результаты аудитов.
- Скриншоты и записи.
- Scoring по 7К.
- Данные клиники.
- Конкурентный анализ.
- Гипотезы quick wins и модулей.

Последовательность действий

- Собрать все наблюдения в единую таблицу потерь.
- Удалить слабые или неподтверждённые выводы.
- Привязать каждую потерю к 7К и этапу patient flow.
- Оценить критичность, влияние и сложность.
- Выделить 5-10 критических потерь.
- Сформировать 7-дневный, 30-дневный и 90-дневный план.
- Упаковать выводы в язык собственника, а не технического специалиста.

Чек-лист диагностики

- Есть краткое резюме для собственника.
- Индекс пациентопотока рассчитан или обозначен как предварительный.
- Каждая потеря имеет доказательство.
- Потери приоритизированы.
- Есть быстрые победы и отдельные модули.
- Следующий шаг логичен и коммерчески понятен.

Результат на выходе

- Готовая Карта потерь пациентов.
- Список критических потерь.
- Приоритеты внедрения.
- Предложение Fix или Growth.

Критерии качества

- Карта не должна быть списком замечаний.
- Она должна показывать систему потерь.
- Технические детали переводятся в управленческие выводы.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Отдавать весь план бесплатно без границ.
- Перегружать документ мелкими замечаниями.
- Не разделять quick wins и платное внедрение.
- Не делать коммерческий мост к следующему продукту.

11. SOP: Контроль качества

Контроль качества

Связь с 7К: Контроль

Цель: Не выпускать клиенту слабые документы, неподтверждённые выводы и хаотичные рекомендации.

Входные данные

- Черновик Карты или отчёта.
- Скриншоты и доказательства.
- Scoring.
- Продуктовая траектория.
- Чек-лист QA.

Последовательность действий

- Проверить структуру документа.
- Проверить наличие доказательств по каждой критической потере.
- Проверить, нет ли общих фраз без действия.
- Проверить связь каждой рекомендации с 7К.
- Проверить реалистичность сроков и границ.
- Проверить, что клиенту не отдано внедрение бесплатно.
- Проверить визуальную читабельность и отсутствие ошибок.

Чек-лист диагностики

- Каждая потеря доказана.
- Нет нелегитимных обещаний выручки.
- Нет задач без связи с patient flow.
- Есть приоритеты.
- Есть следующий шаг.
- Документ понятен собственнику.
- Нет наложений, обрезок, опечаток и технического мусора.

Результат на выходе

- Документ допущен к отправке.
- Или список исправлений с ответственными и дедлайном.

Критерии качества

- QA имеет право заблокировать отправку.
- Слабая формулировка исправляется до клиента.
- Нельзя сдавать “почти готово”.

Типовые ошибки, которые нельзя допускать

- Проверять только орфографию.
- Не сверять доказательства.
- Не смотреть коммерческую логику.
- Пропускать обещания без оговорок.

12 / FINAL STANDARD

Финальный стандарт производства

Delivery SOP считается внедрённым, если все участники производства могут выполнить диагностику одинаково: с доказательствами, привязкой к 7К, понятным выводом для собственника и коммерческим мостом к следующему продукту.

Контрольный вопрос	Правильный стандарт
Понятно, какую потерю закрывает задача?	Да. Каждая задача привязана к конкретному К и этапу patient flow.
Есть доказательство вывода?	Да. Скриншот, запись, метрика, ссылка, CRM-данные или сравнение с конкурентом.
Вывод понятен собственнику?	Да. Не технический шум, а влияние на запись, лечение, возврат или управляемость.
Приоритеты ясны?	Да. Есть быстрые победы, критические потери и задачи для модуля.
Границы продукта соблюдены?	Да. В Карту не включено бесплатное внедрение. В Fix не включены неограниченные работы.
Есть следующий шаг?	Да. Карта ведёт в Fix/Growth, отчёт ведёт в следующий цикл или модуль.

Чек-лист перед отправкой клиенту

- Документ не содержит общих фраз без действия.
- Нет выводов без доказательств.
- Все рекомендации связаны с 7К.
- Есть понятные приоритеты: 7 дней, 30 дней, 90 дней.
- Соблюдены границы платного продукта.
- Есть коммерческий следующий шаг.
- Вёрстка проверена: нет наложений, обрезок и выходов за границы.

Финальная формула: ШАРiK digital производит не набор задач, а управляемое снижение потерь пациентопотока. Производство считается качественным только тогда, когда клиент видит: где терял, что закрыли, что осталось и какой следующий шаг усиливает систему.